DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: GONZALO GIRALDO VARGAS **Identificación** CC 4527049
Edad: 75 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS S.A CONTRIBUTIVO-2025
Sala: QUIROFANO 6 **Fecha programación de cirugía:** 01/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
2	**530301**	**HERNIORRAFIA INGUINAL ENCARCELADA VIA ABIERTA**	Y38	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: INGLE DERECHA

1	**544104**	**OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA**	Y40	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: INGLE DERECHA

1	**547401**	**EVENTRORRAFIA CON COLOCACION DE MALLA**	Y44	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: INGLE DERECHA

1	**867203**	**COLGAJO LOCAL DE PIEL COMPUESTO DE VECINDAD ENTRE CINCO A DIEZ CENTIMETROS CUADRADOS**	Y44	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: INGLE DERECHA

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES100 DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

530301 **HERNIORRAFIA INGUINAL ENCARCELADA VIA ABIERTA**
544104 **OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA**
547401 **EVENTRORRAFIA CON COLOCACION DE MALLA**
867203 **COLGAJO LOCAL DE PIEL COMPUESTO DE VECINDAD ENTRE CINCO A DIEZ CENTIMETROS CUADRADOS**

Dx Preoperatorio: K400 HERNIA INGUINAL BILATERAL CON OBSTRUCCION SIN GANGRENA

Dx Postoperatorio: K412 HERNIA FEMORAL BILATERAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA

Tipo de Herida: LIMPIA CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** RAQUIDEA **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 5 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 01/11/26 **Fecha Final** 01/11/26
Hora Inicio 14:45:00 **Hora Final** 15:20:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:

1. PAUSA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA FIRMA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, PROFILAXIS ANTIBIÓTICA, MARCACIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO.
2. BAJO ANESTESIA GENERAL, ASEPSIA Y ANTISEPSIA, COLOCACION DE CAMPOS QUIRURGICOS.
3. INCISIÓN EN LA REGIÓN INGUINAL DERECHA, DISECCIÓN POR PLANOS CON ELECTROBISTURÍ, INGRESO AL CANAL INGUINAL, SIN EVIDENCIA DE HERNIA INGUINAL DIRECTA O INDIRECTA.
4. INGRESO AL ESPACIO PREPERITONEAL. SE IDENTIFICA HERNIA FEMORAL ENCARCELADA. SE AMPLIA EL ANILLO FEMORAL, SE REDUCE EL SACO HERNIARIO CON EL CONTENIDO ENCARCELADO.
5. SE ABRE EL SACO HERNIARIO. SEGMENTO DE EPIPLON MAYOR ISQUEMICO. SE PINZA, CORTA Y LIGA CON POLIGLACTINA 1-0, SE REDUCE EL MUÑON A LA CAVIDAD PERITONEAL.
6. PINZAMIENTO, CORTE Y LIGADURA DEL SACO HERNIARIO.
7. CIERRE DEL ANILLO HERNIARIO FEMORAL CON PUNTO DE POLIGLACTINA 1-0.
8. DISECCIÓN DEL ESPACIO PREPERITONEAL. SE TALLAN COLGAJOS MIOFASCIALES DE MÁS DE CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS.
9. SE COLOCA MALLA DE POLIPROPILENO DE 15 CM X 15 CM, SE FIJA AL LIGAMENTO DE COOPER CON TRES PUNTOS DE POLIPROPILENO 0.
10. SE EXTIENDE LA MALLA EN EL ESPACIO PREPERITONEAL
11. REVISION DE HEMOSTASIA, RECUENTO DE MATERIAL, GASAS Y COMPRESAS COMPLETO INFORMADO POR LA INSTRUMENTADORA.

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

12. CIERRE DE LA PARED ABDOMINAL POR PLANOS CON POLIGLACTINA 1-0.
13. CIERRE DE PIEL CON POLIPROPILENO 3-0, SUTURA INTRADERMICA. SE CUBRE LA HERIDA CON GASAS ESTÉRILES Y MICROPORE.

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

HERNIA FEMORAL DERECHA (NYHUS IIIC). SACO HERNIARIO DE 5 CM CON CONTENIDO DE SEGMENTO DE EPIPLON MAYOR ENCARCELADO, CON CAMBIOS ISQUEMICOS.

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ESP20	HAROLD DARIO PINEDA PALACIO	ANESTESIOLOGO
MG39	JUAN CARLOS GOMEZ GARCIA	AYUDANTE

Diego F. Quintero Ladino
Cirujano General
Universidad Nacional de Colombia

DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO
Reg. 17337
CIRUGIA GENERAL

***** FIN DEL REPORTE *****